

REINGRESO

Ficha del conjunto de datos de altas hospitalarias

Referencia SRS/CAL/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 8 800 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un alta hospitalaria • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de altas hospitalarias registradas en un servicio regional de salud. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las duraciones se expresan en días naturales y los recuentos de comorbilidades proceden de la codificación del conjunto mínimo básico de datos.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
servicio_alta	Servicio hospitalario responsable del alta. Procede de la última extracción del almacén de datos corporativo.
edad	Edad del paciente en el momento del alta.
sexo	Sexo registrado en la historia clínica.
dias_ingreso	Duración del ingreso hospitalario en días.
comorbilidades	Número de patologías crónicas activas codificadas en el episodio.
ingresos_previos_anio	Ingresos hospitalarios del paciente en los doce meses anteriores.
destino_alta	Destino del paciente al recibir el alta.
informe_alta_estructurado	Indica si el alta se acompañó de informe estructurado con plan de cuidados. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
polimedicacion	Número de principios activos prescritos en el informe de alta.
vive_solo	Indica si el paciente vive solo en su domicilio.
hospital	Hospital en que se produjo el alta.
tipo_ingreso	Carácter del ingreso que origina el alta.
fecha_alta	Fecha en que se produjo el alta hospitalaria.
reingreso_30d	Indica si el paciente volvió a ingresar en un hospital del servicio regional dentro de los treinta días siguientes al alta.
distrito_residencia	Distrito sanitario de residencia del paciente. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.
seguimiento_primaria_7d	Indica si se concertó cita con atención primaria en los siete días posteriores. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Edad (años)	8 800	0	65,43	16,67	18,00	54,00	65,00	77,00	100,00
Días de ingreso	8 800	0	0,06	26,82	-99,00	3,00	6,00	9,00	50,00
Comorbilidades activas	8 800	0	2,44	2,66	0,00	0,00	2,00	4,00	26,00
Ingresos previos en el año	8 800	0	0,59	1,08	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00
Fármacos prescritos al alta	8 800	0	5,99	4,46	0,00	3,00	5,00	8,00	33,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Servicio que da el alta	22	0	medicina interna	1 853 (21,1 %)
Sexo	2	0	hombre	4 513 (51,3 %)
Destino al alta	4	0	domicilio	6 661 (75,7 %)
Informe de alta estructurado	2	0	sí	5 093 (57,9 %)
Vive solo	2	0	no	6 632 (75,4 %)
Hospital	6	0	hospital D	1 522 (17,3 %)
Tipo de ingreso	3	0	urgente	5 685 (64,6 %)
Fecha del alta	540	0	06/07/2024	32 (0,4 %)
Reingreso en treinta días	2	0	no	7 373 (83,8 %)
Distrito de residencia	10	0	distrito 9	951 (10,8 %)
Cita en primaria a siete días	2	0	no	5 229 (59,4 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Servicio que da el alta	<i>n</i>	%
medicina interna	1 853	21,1
cirugía general	1 107	12,6
cardiología	1 046	11,9
traumatología	992	11,3
neumología	870	9,9
digestivo	672	7,6
medicina interna	230	2,6
MEDICINA INTERNA	217	2,5
cirugia general	165	1,9
traumatología	156	1,8
CIRUGÍA GENERAL	154	1,8
cirugía general	152	1,7
TRAUMATOLOGÍA	143	1,6
CARDIOLOGÍA	142	1,6
traumatologia	132	1,5
cardiología	130	1,5
cardiologia	128	1,5
neumología	126	1,4
NEUMOLOGÍA	114	1,3
neumologia	109	1,2
digestivo	84	1,0
DIGESTIVO	78	0,9
Total	8 800	100,0

Distrito de residencia	<i>n</i>	%
distrito 9	951	10,8
distrito 8	885	10,1
distrito 7	885	10,1
distrito 5	884	10,0
distrito 3	881	10,0
distrito 2	878	10,0
distrito 6	867	9,9
distrito 4	866	9,8
distrito 10	865	9,8
distrito 1	838	9,5
Total	8 800	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas

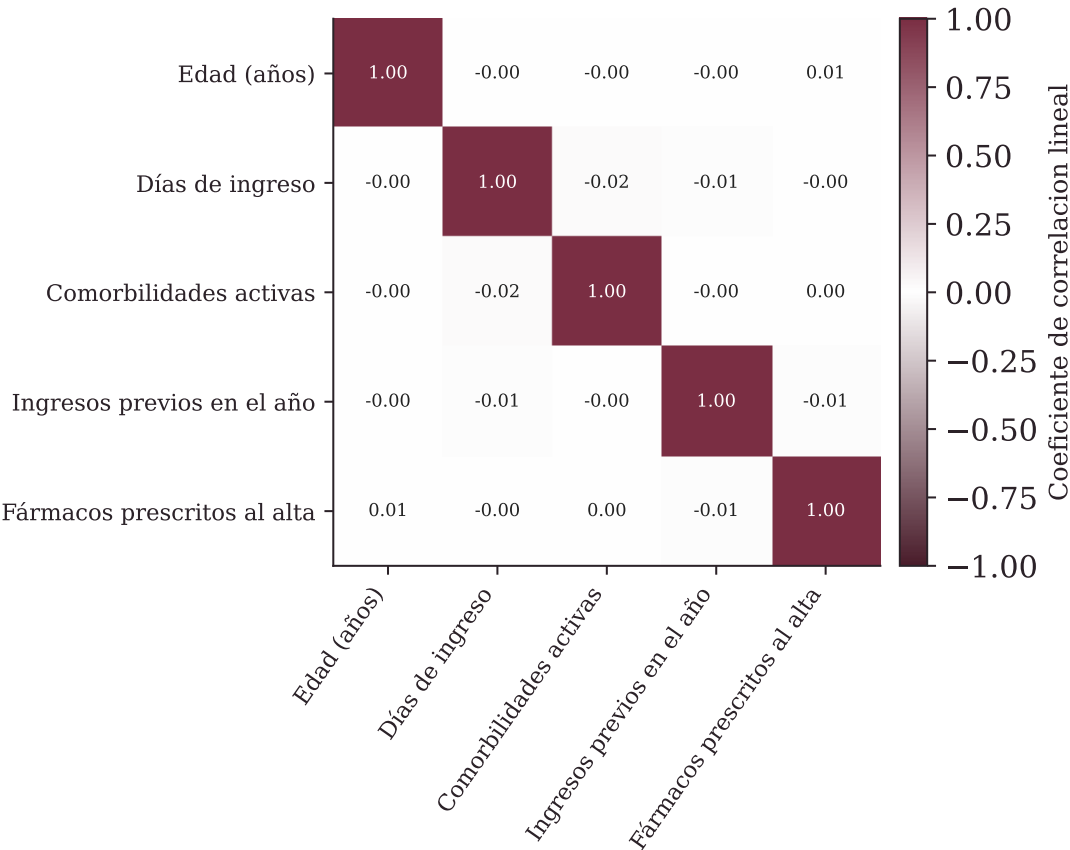


Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.

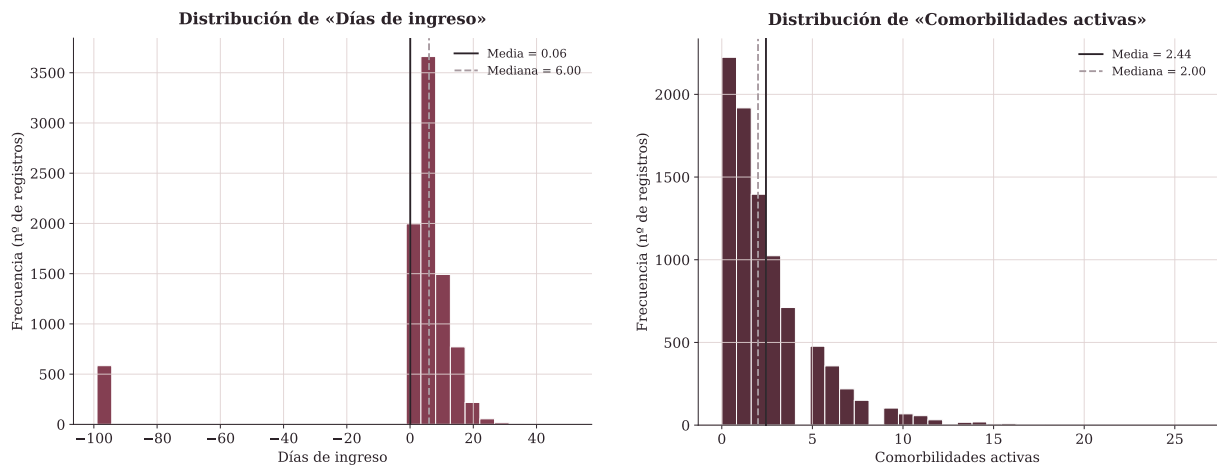


Figura 2. Distribución de «Días de ingreso» (izquierda) y de «Comorbilidades activas» (derecha).

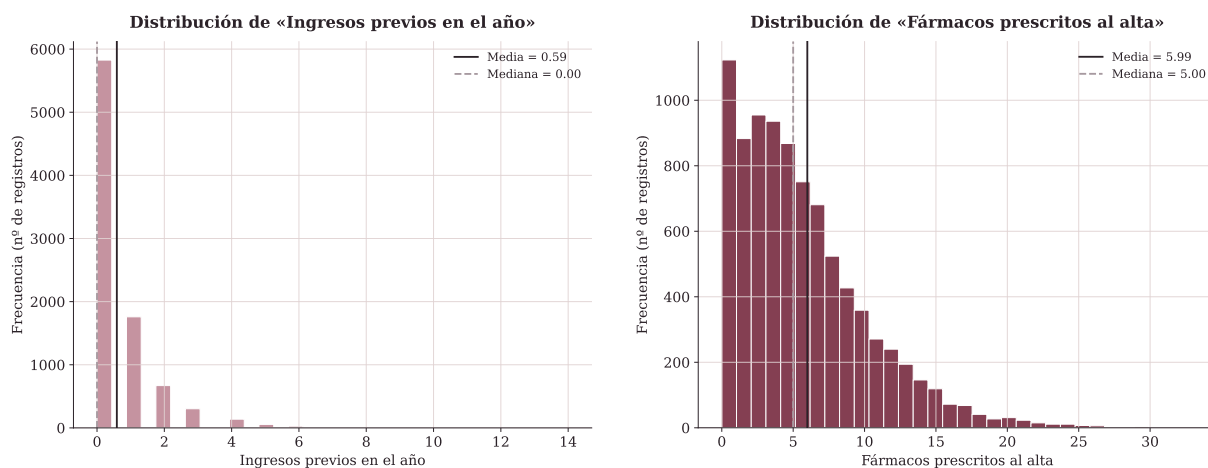


Figura 3. Distribución de «Ingresos previos en el año» (izquierda) y de «Fármacos prescritos al alta» (derecha).

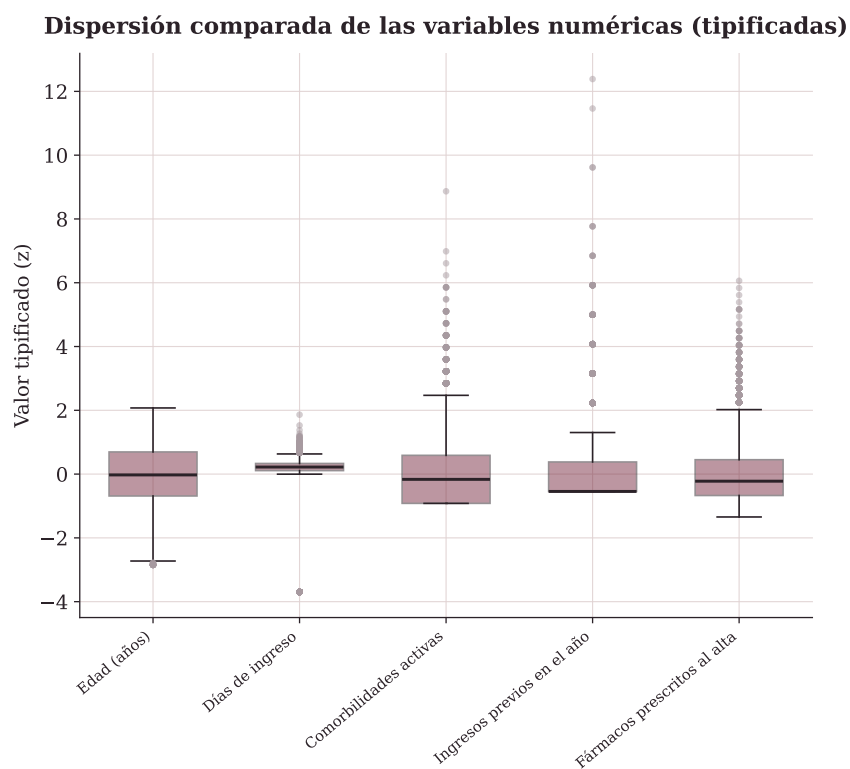


Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.

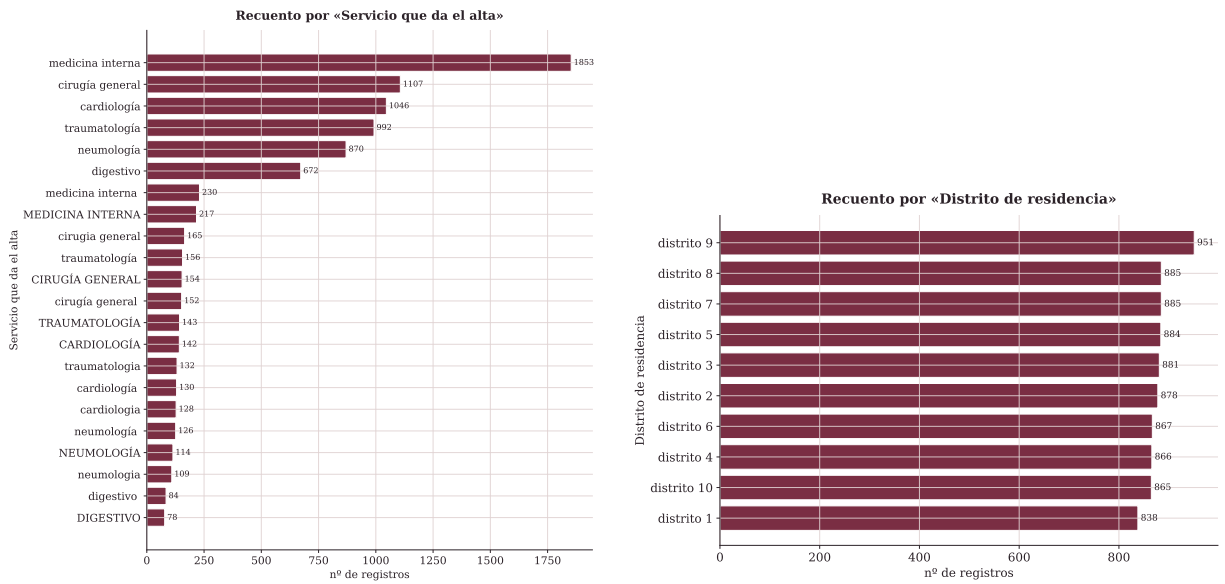


Figura 5. Recuento de registros por «Servicio que da el alta» (izquierda) y por «Distrito de residencia» (derecha).

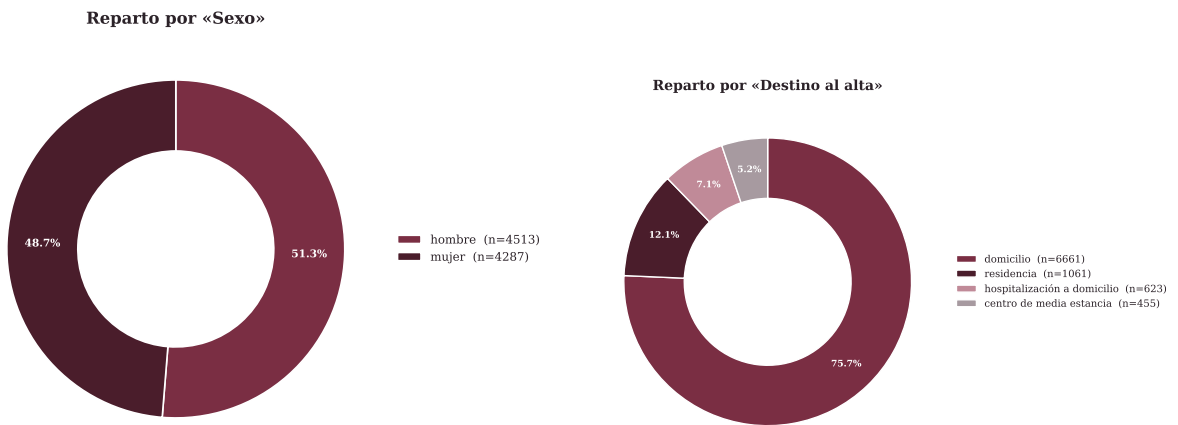


Figura 6. Reparto de registros por «Sexo» (izquierda) y por «Destino al alta» (derecha).

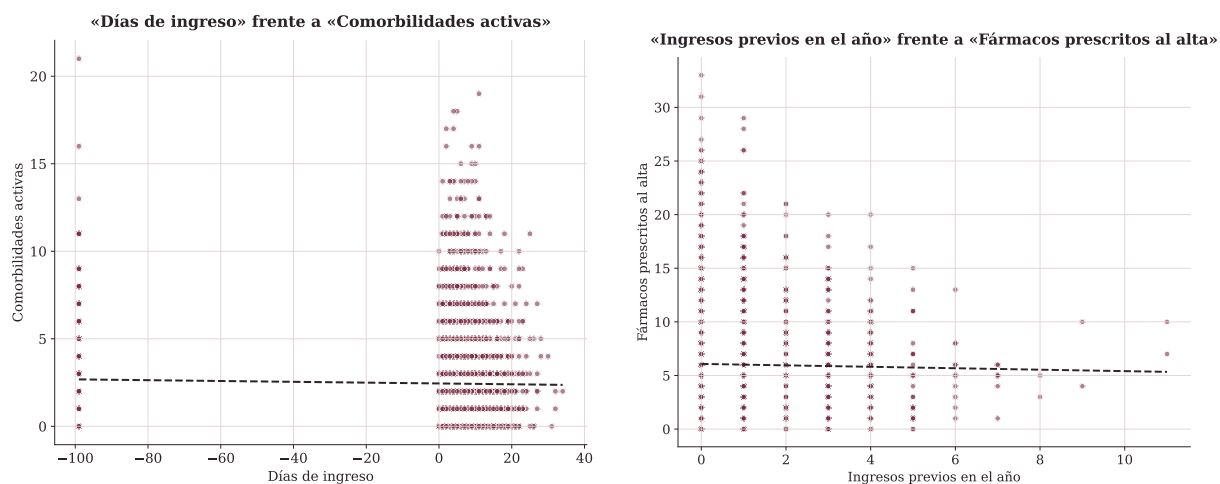


Figura 7. «Días de ingreso» frente a «Comorbilidades activas» (izquierda) y «Ingresos previos en el año» frente a «Fármacos prescritos al alta» (derecha).

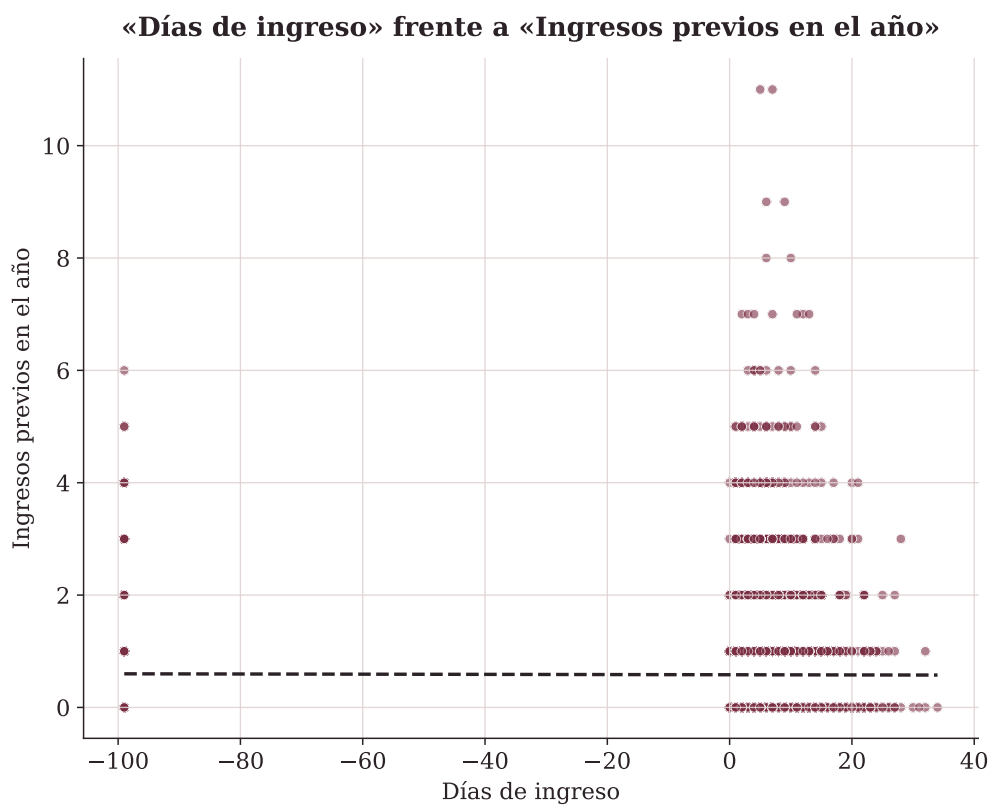


Figura 8. «Días de ingreso» frente a «Ingresos previos en el año».

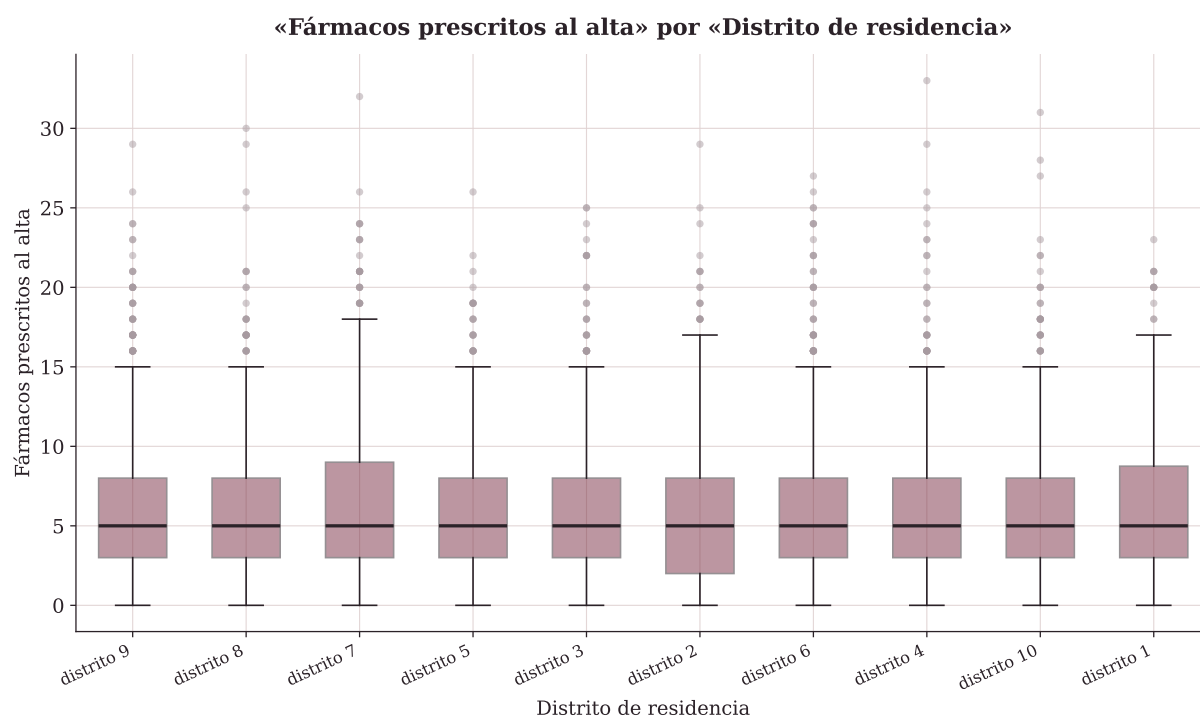


Figura 9. «Fármacos prescritos al alta» desagregado por «Distrito de residencia».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información clínica del episodio, como el diagnóstico principal codificado o la gravedad del grupo relacionado por el diagnóstico, afinaría el riesgo? Segundo, ¿qué datos del entorno del paciente, como el apoyo social disponible o la cobertura de cuidados domiciliarios, explicarían la vuelta al hospital? Tercero, ¿qué variables del circuito posterior, como las visitas a primaria efectivamente realizadas, permitirían evaluar la continuidad asistencial? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de historia clínica y episodio las uniría al fichero actual?